* ▼Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri beklenmektedir.

Beşeri tıbbi ürünün adı: SOLIRIS® (Eculizumab) 300 mg/30 ml konsantre infüzyon çözeltisi **Kantitatif bileşimi ve ambalaj içeriği:** Konsantre infüzyon çözeltisi içeren 30 ml'lik her bir flakon 300 mg eculizumab içerir (10 mg/ml). **Endikasyonları:** Erişkinlerde ve çocuklarda paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH), atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS) ve jeneralize miyastenia gravis (jMG) tedavisinde endikedir. Klinik semptom ve hemoliz gösteren yüksek hastalık aktivitesi olan PNH hastalarında klinik fayda kanıtı, transfüzyon öyküsünden bağımsız olarak gösterilmiştir. Erişkinlerde Anti-AChR antikorları için pozitif serolojik teste sahip, MGFA (Amerika Miyastenia Gravis Vakfı) klinik sınıflandırma derecesi II ila IV ve MG-ADL toplam skoru ≥6 olan jeneralize miyastenia gravis (jMG) hastalarında şu koşullarda endikedir; iki ya da daha fazla immünosupresan tedavi (ya kombinasyon halinde ya da monoterapi olarak) ile en az bir yıl başarısız tedavi veya en az bir immünosupresan tedavi ile başarısız olmuş, semptom kontrolü için kronik plazma değişimi veya IVIg gerektiren durumlarda (önceki 12 ay içerisinde en az 3 ayda bir kas güçsüzlüğü kontrolü için düzenli olarak plazma değişimi veya IVIg tedavisi almış). Bu şekilde tedaviye devam eden hastalarda, 12 haftalık kullanımını takiben MG-ADL toplam skorunda iyileşmenin 2 puanın altında olması durumunda tedavi sonlandırılmalıdır. Çocuklarda, en az 1 IST ile ≥ 1 yıl tedavide, şu şekilde tanımlanan tedavi başarısızlığı: (i) Günlük yaşam aktivitelerinde bozulmanın eşlik ettiği kalıcı güçsüzlük (ii) tedavi sırasında Myastenia gravis alevlenmesi ve/veya krizi veya (iii) Yan etki veya komorbid duruma/durumlara bağlı olarak IST'lere toleranssızlık veya semptomların kontrolü için PD veya IVIg idamesinin gerekmesi (yani, taramadan önceki son 12 ay boyunca en az 3 ayda bir kas güçsüzlüğünün tedavisi için düzenli olarak PD veya IVIg'ye ihtiyaç duyan hastalar) durumlarından bir veya daha fazlasına sahip olan 6-18 yaş arası pediatrik gMG hastalarında endikedir. Erişkinlerde Relaps eğilimi gösteren, anti-akuaporin-4 (AQP4) antikoru pozitif olan hastalarda nöromiyelitis optika spektrum bozukluğunda da endikedir. **Pozoloji ve uygulama şekli:** *Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri'de (PNH):* Erişkin hastalar (≥18 yaş) için PNH doz uygulaması rejimi 4 haftalık bir başlangıç fazından ve bunu takip eden bir idame fazından oluşmaktadır: *Başlangıç fazı:* İlk 4 hafta boyunca her hafta 25-45 dakikalık intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 600 mg SOLIRIS®. *İdame fazı:* Beşinci haftada 25-45 dakika intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 900 mg SOLIRIS®, ardından her 14±2 günde bir 25-45 dakikalık intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 900 mg SOLIRIS®. *Atipik Hemolitik Üremik Sendrom'da (aHÜS), refrakter jeneralize Miyastenia Gravis'te (jMG) ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu'nda (NMOSB):* Erişkin hastalar (≥18 yaş) için aHÜS, refrakter jMG ve NMOSB doz uygulaması rejimi, 4 haftalık başlangıç fazından ve bunu takip eden idame fazından oluşmaktadır: *Başlangıç fazı:* İlk 4 hafta boyunca her hafta 25-45 dakikalık intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 900 mg SOLIRIS®. *İdame fazı:* Beşinci haftada 25-45 dakika intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 1200 mg SOLIRIS®, ardından her 14±2 günde bir 25–45 dakikalık intravenöz infüzyon yoluyla uygulanan 1200 mg SOLIRIS®. *Refrakter jMG:* Mevcut veriler klinik yanıtın genellikle 12 haftalık SOLIRIS® tedavisi ile elde edildiğini işaret etmektedir. Tedavinin bırakılması 12. hafta itibariyle terapötik fayda kanıtı göstermeyen hastada düşünülmelidir. Tedavi takibi: SOLIRIS®'in bırakılması klinik olarak endike olmadıkça, SOLIRIS® tedavisinin hastanın yaşamı boyunca devam ettirilmesi önerilmektedir. PNH hastaları, serum laktat dehidrogenaz (LDH) düzeyleri de dahil olmak üzere intravasküler hemoliz bulgu ve belirtileri açısından takip edilmelidir. aHÜS hastaları, trombotik mikroanjiyopatinin (TMA) bulgu ve belirtileri açısından takip edilmelidir. SOLIRIS®'i intravenöz (puşe) ya da bolus enjeksiyon olarak uygulamayınız. SOLIRIS® yalnızca KÜB'te tarif edildiği şekilde intravenöz infüzyon yoluyla uygulanmalıdır. Hastaya yapılan uygulama sırasında seyreltilmiş SOLIRIS® çözeltisinin ışıktan korunmasına gerek bulunmamaktadır. Hastalar infüzyonu takiben bir saat boyunca izlenmelidir. SOLIRIS® uygulaması sırasında advers bir olay meydana gelirse, hekimin takdirine göre infüzyon yavaşlatılabilir ya da durdurulabilir. Eğer infüzyon yavaşlatılırsa, toplam infüzyon süresi erişkinlerde ve ergenlerde (12 ila 18 yaş) iki saati ve 12 yaşın altındaki çocuklarda dört saati geçmemelidir. **Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Karaciğer Yetmezliği:** Karaciğer yetmezliği olan hastalarda SOLIRIS®'in güvenliliği ve etkililiği incelenmemiştir. **Böbrek Yetmezliği:** Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. **Pediyatrik popülasyon:** Vücut ağırlığı ≥40 kg olan pediyatrik PNH,aHÜS veya refrakter jMG hastaları, erişkin doz uygulaması önerilerine göre tedavi edilir. Vücut ağırlığı <40 kg olan pediyatrik PNH, aHÜS veya refrakter jMG hastalarında SOLIRIS® doz uygulama rejimi şu şekildedir: Vücut ağırlığı: 5 ila <10 kg olan hastada başlangıç fazı: İlk hafta 300 mg. İdame fazı: 2. haftada 300 mg; ardından her 3 haftada bir 300 mg. Vücut ağırlığı: 10 ila <20 kg olan hastada başlangıç fazı: İlk hafta 600 mg. İdame fazı: 2. haftada 300 mg; ardından her 2 haftada bir 300 mg. Vücut ağırlığı 20 ila <30 kg olan hastada başlangıç fazı ilk iki hafta, haftada bir 600mg. İdame fazı 3. haftada 600 mg; ardından her 2 haftada bir 600 mg. Vücut ağırlığı 30 ila <40 kg olan hastada başlangıç fazı ilk iki hafta, haftada bir 600 mg. İdame fazı 3. haftada 900 mg; ardından her 2 haftada bir 900 mg şeklindedir. Vücut ağırlığı 40 kg'dan düşük kilolu PNH hastalarında veya refrakter jMG hastalarında çalışılmamıştır. Vücut ağırlığı 40 kg'dan düşük kilolu olan pediyatrik PNH veya refrakter jMG hastalarında kullanılacak SOLIRIS® pozolojisi, pediyatrik aHÜS hastaları için verilen, vücut ağırlığına dayalı doz önerileriyle aynıdır. SOLIRIS® ile tedavi edilen aHÜS ve PNH

hastalarında mevcut olan farmakokinetik (FK)/farmakodinamik (FD) verilerine dayanarak, pediyatrik hastalar için bu vücut ağırlığına dayalı doz rejiminin, erişkinlerdekine benzer bir etkililik ve güvenlilik profili ile sonuçlanması beklenmektedir. Vücut ağırlığı 40 kg'dan düşük kilolu refrakter jMG hastalarında, bu vücut ağırlığına dayalı doz rejiminin de erişkinlerdekine benzer bir etkililik ve güvenlilik profili ile sonuçlanması beklenmektedir. SOLIRIS® pediyatrik NMOSB hastalarında çalışılmamıştır. Eşzamanlı plazmaferez (PF), plazma değiş-tokuş (PD), ya da taze donmuş plazma infüzyonu (Pİ) uygulanması durumunda ek SOLIRIS® dozu gereklidir. Altı yaşından küçük refrakter jMG hastası çocuklarda SOLIRIS®'in güvenliliği ve etkiliği belirlenmemiştir. On sekiz yaşından küçük NMOSB hastası çocuklarda SOLIRIS®'in güvenliliği ve etkiliği belirlenmemiştir.**Geriyatrik popülasyon:** SOLIRIS® 65 yaş ve üzeri hastalara uygulanabilir. Yaşlı kişiler tedavi edilirken özel bir önlemin gerekli olduğuna işaret eden herhangi bir kanıt mevcut değildir. Bununla birlikte bu hasta popülasyonunda SOLIRIS® ile elde edilen deneyim halen sınırlıdır. **Kontrendikasyonlar:** Eculizumab, mürin proteinleri ya da diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir. İyileşmemiş *Neisseria meningitidis* enfeksiyonu olan hastalarda, aşılama sonrasında 2 haftaya kadar uygun antibiyotiklerle profilaktik tedavi almamış ve hali hazırda *Neisseria meningitidis*'e karşı aşılanmamış hastalarda SOLIRIS® tedavisi başlatılmamalıdır. **Özel kullanım uyarıları ve önlemleri:** *Meningokokkal enfeksiyon:* SOLIRIS® tedavisi, etki mekanizmasından dolayı hastaların meningokokkal *(Neisseria meningitidis)* enfeksiyona karşı duyarlılığını artırmaktadır. Herhangi bir serogrubun yol açtığı meningokokkal hastalık meydana gelebilir. SOLIRIS® tedavisini geciktirme riski, bir meningokokkal enfeksiyonu gelişme risklerinden ağır basmadıkça, enfeksiyon riskini azaltmak için tüm hastalar, SOLIRIS® kullanımından en az 2 hafta önce aşılanmalıdır. Ayrıca, tetravalan meningokokkal aşı uygulaması sonrasında 2 (iki) haftadan daha az süre içinde SOLIRIS® tedavisine başlayan hastalar aşılamadan sonraki 2 (iki) haftaya kadar uygun profilaktik antibiyotik tedavisi almalıdır. Yaygın patojenik meningokkal serogruplardan korunmada, A, C, Y, W 135 serogruplarına karşı aşılama önerilmektedir. Uygulanabilir olduğunda da B serogrubuna karşı aşı önerilmektedir. Hastalar, aşı kullanımına yönelik mevcut ulusal aşı kılavuzlarına göre aşılanmalıdır. Aşılama, komplemanda daha ileri aktivasyona neden olabilir. Bunun sonucunda, PNH, aHÜS ve refrakter jMG dahil kompleman-aracılı hastalıkları olan hastalar, altta yatan hastalıklarının hemoliz (PNH), TMA (aHÜS), MG alevlenmesi (refrakter jMG) veya relaps (NMOSB) gibi bulgu ve belirtilerinde artış deneyimleyebilir. Bu nedenle, önerilen aşılama sonrasında hastalık belirtileri açısından hastalar yakından takip edilmelidir. Meningokokkal enfeksiyonu önlenmek için aşılama yeterli olmayabilir. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımına yönelik resmi kılavuzlar göz önünde tutulmalıdır. SOLIRIS® ile tedavi edilen hastalarda ciddi veya ölümcül meningokokkal enfeksiyon olguları bildirilmiştir. Sepsis, SOLIRIS® ile tedavi edilen hastalarda meningokokkal enfeksiyonlarının yaygın bir belirtisidir. SOLIRIS® kullanan tüm hastalar meningokokkal enfeksiyonun erken bulguları açısından izlenmeli, enfeksiyondan şüphelenildiği durumlarda acilen değerlendirilmeli ve gerekirse uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. *Diğer sistemik enfeksiyonlar:* Etki mekanizmasından dolayı SOLIRIS® tedavisi, aktif sistemik enfeksiyonların olduğu hastalara dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır. Hastaların enfeksiyonlara, özellikle *Neisseria* ve kapsüllü bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara duyarlılığı artmış olabilir. Dissemine gonokokkal enfeksiyonlar dahil Neisseria türleri ile ciddi enfeksiyonlar (*Neisseria meningitidis* dışında) bildirilmiştir. Hekimler gonoreden korunma konusunda hastalara bilgi vermelidir. *İnfüzyon reaksiyonları:* SOLIRIS®'in uygulanması infüzyon reaksiyonlarına ya da alerjik veya aşırı duyarlılık reaksiyonlarına (anafilaksi de dahil) yol açabilecek immünojenisiteye neden olabilir. Şiddetli infüzyon reaksiyonları görülen tüm hastalarda SOLIRIS® uygulaması durdurulmalı ve uygun tıbbi tedavi uygulanmalıdır. *İmmunojenisite:* Tüm klinik çalışmalar boyunca SOLIRIS® ile tedavi edilen hastalarda, nadiren, antikor yanıtları tespit edilmiştir. Antikor gelişimi ile klinik yanıt ya da advers olaylar arasında herhangi bir korelasyon gözlenmemiştir. *İmmünizasyon:* SOLIRIS® ile tedaviye başlanmadan önce, PNH, aHÜS, refrakter jMG ve NMOSB hastalarında güncel immünizasyon kılavuzlarına göre immünizasyonun başlatılması önerilmektedir (bkz. Meningokokkal Enfeksiyon). 18 yaşından küçük olan hastalar, *Haemophilus influenza* ve pnömokok enfeksiyonlarına karşı aşılanmalıdırlar ve her bir yaş grubu için ulusal aşılama önerilerine kesin suretle uyulması gerekmektedir. *Antikoagülan tedavi:* SOLIRIS® tedavisi antikoagülan tedavisini değiştirmemelidir. *Laboratuvar takibi:* PNH hastaları, serum LDH düzeyleri de dahil olmak üzere intravasküler hemoliz bulgu ve belirtileri açısından takip edilmelidir. SOLIRIS® tedavisi gören PNH hastaları da benzer şekilde, LDH düzeyleri ölçülerek intravasküler hemoliz için takip edilmelidir ve bu hastalarda, idame fazı boyunca önerilen 14 ± 2 gün doz uygulaması takvimi içinde doz ayarlaması gerekli olabilir (her 12. güne kadar). SOLIRIS® tedavisi gören aHÜS hastaları, trombosit sayımları, serum LDH ve serum kreatinin ölçümleri ile TMA için takip edilmelidir ve bu hastalarda, idame fazı boyunca önerilen 14 ± 2 gün doz uygulaması takvimi içinde doz ayarlaması gerekli olabilir (her 12. güne kadar). *Yardımcı maddeler: Sodyum:* Bu tıbbi ürün, 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile seyreltildikten sonra, maksimum dozda 240 mL'de 0,88 g sodyum içerir; bu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün bir erişkin için önerilen maksimum günlük 2 g sodyum alımının %44'üne eşdeğerdir.Bu tıbbi ürün, 4,5 mg/mL (%0,45) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile seyreltildikten sonra, maksimum dozda 240 mL'de 0,67 g sodyum içerir; bu, DSÖ'nün bir erişkin için önerilen maksimum günlük 2 g sodyum alımının %33,5'ine

eşdeğerdir. *Polisorbat 80:* Bu ilaç, her flakonda (30 mL flakon), yetişkin hastalar ve 10 kg'dan fazla vücut ağırlığına sahip pediyatrik hastalara yönelik maksimum dozda 0,66 mg/kg veya daha azına eş değer ve 5 ila <10 kg vücut ağırlığına sahip pediyatrik hastalara yönelik maksimum dozda 1,32 mg/kg veya daha azına eş değer 6,6 mg polisorbat 80 içerir. Polisorbat, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. **Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri:** SOLIRIS® ile herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır. Eculizumabın, rituksimabın kompleman-bağımlı sitotoksisitesi üzerindeki potansiyel inhibitör etkisine dayanarak, eculizumab, rituksimabın beklenen farmakodinamik etkilerini azaltabilir. Plazma değiş-tokuşun (PD), plazmaferezin (PF), taze donmuş plazma infüzyonunun (Pİ) ve intravenöz immunglobulinin (IVIg) eculizumab serum düzeylerini düşürdüğü gösterilmiştir. Ek eculizumab dozu bu uygulamalarda gereklidir. Eculizumabın intraveöz immunglobulin (IVIg) ile eş zamanlı kullanılması, eculizumabın etkililiğini düşürebilir. Düşen eculizumab etkililiği için yakından takip edilmelidir. Eculizumabın neonatal Fc reseptör (FcRn) blokörleri ile eş zamanlı kullanılması, sistemik maruziyeti azaltabilir ve eculizumabın etkililiğini düşürebilir. Düşen eculizumab etkililiği için yakından takip edilmelidir. **Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon):** Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlarda gebeliği önlemek için tedavi sırasında ve eculizumab tedavisinin son dozundan sonra en az 5 ay süreyle uygun bir doğum kontrol yönteminin kullanılması göz önünde bulundurulmalıdır. **Gebelik dönemi:** Gebelik kategorisi C'dir. SOLIRIS® gebelik döneminde sadece kesin olarak gerekli olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Gebelik sırasında bu tür bir tedavi gerekli görüldüğü takdirde, yerel kılavuzlar doğrultusunda yakından maternal ve fetal takip önerilmektedir. **Laktasyon dönemi:** Mevcut sınırlı veriler eculizumabın insan sütü ile atılmadığını düşündürdüğünden, emzirilen yenidoğan/bebek üzerinde etki beklenmemektedir. Bununla birlikte, mevcut verilerin sınırlı olmasından dolayı, annenin eculizumaba klinik ihtiyacının yanında emzirmenin gelişim ve sağlık açısından yararları ve emzirilen çocuk üzerinde eculizumaba veya altta yatan maternal duruma bağlı muhtemel advers etkiler göz önünde bulundurulmalıdır. **Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler:** Etkisi bulunmamaktadır ya da göz ardı edilebilir etkisi bulunmaktadır. **İstenmeyen etkiler:** En yaygın advers reaksiyon baş ağrısı (çoğunlukla başlangıç fazında görülmüştür) ve en ciddi advers reaksiyon meningokokkal sepsistir. Her bir sıklık grubunda advers reaksiyonlar, azalan ciddiyet sırasına göre detaylı olarak KÜB'de sunulmaktadır. **Doz aşımı:** Klinik çalışmaların hiçbirinde doz aşımı vakası bildirilmemiştir. **Raf ömrü:** 30 ay. Seyreltildikten sonra, tıbbi ürün hemen kullanılmalıdır. Bununla birlikte kimyasal ve fiziksel olarak 2ºC - 8°C'de 24 saat stabil kaldığı gösterilmiştir. **Saklamaya yönelik özel tedbirler:** 2ºC - 8ºC arasında buzdolabında saklayınız. Dondurmayınız. Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız. Orijinal ambalajındaki flakonlar yalnızca bir kez en fazla 3 günlük bir süre için buzdolabından çıkarılabilir. Bu sürenin sonunda ürün tekrar buzdolabına konulabilir. **Ruhsat sahibi:** Alexion İlaç Ticaret Ltd. Şti. İçerenköy Mahallesi Umut Sk. Quick Tower Sit. No: 10-12/73 Ataşehir/İstanbul Tel: + (90) 216 251 70 00 Faks: + (90) 216 251 70 99 **Ruhsat Tarihi ve Numarası:** 02.10.2015 - 2015/806 **Güncel KÜB onay tarihi:** 28.10.2025 **KÜB özeti onay tarihi:** 01.04.2026 **Versiyonu: 25.0**. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır. SOLIRIS® Risk Yönetim programı ve kontrollü dağıtım kapsamında kısıtlanmış reçete ile satılır. 19.12.2025 tarihi itibariyle Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil): SOLIRIS® (Eculizumab) 300 mg/30 ml konsantre infüzyon çözeltisi 254.690,26 TL.

* Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).